

Il monotropismo e la sua ragnatela di comorbidità: legami diretti e indiretti con condizioni comportamentali, psichiatriche e neuroevolutive

Una breve ricerca citata.

Sintesi esecutiva

Il **monotropismo** (Murray, Lawson & Lesser, 2005) è una teoria dell'attenzione autistica che inquadra l'autismo come una differenza nell'*allocazione delle risorse*: una mente monotropica concentra le risorse di elaborazione in un piccolo numero di "tunnel di attenzione" altamente attivi, lasciando meno risorse per i canali periferici. Una misura di autovalutazione del 2023 — il **Monotropism Questionnaire (MQ)** — fornisce la prima validazione empirica, mostrando che le persone autistiche e con ADHD ottengono punteggi significativamente più alti dei controlli non-autistici/senza-ADHD [1][2][3]. Un modello strettamente correlato e sottoposto a revisione paritaria, il conto dell'**allocazione atipica delle risorse** di Goldknopf, sostiene che la stessa attenzione ristretta-intensa può tenere insieme le caratteristiche sensoriali, sociali, esecutive e motorie dell'autismo — pur avvertendo che "molto probabilmente è un fattore nelle persone autistiche con forti sintomi sensoriali", non l'unica causa [4].

Poiché il monotropismo è una teoria di *come si spendono le risorse*, plausibilmente si ripercuote in molti domini. Il quadro onesto, però, si divide in tre livelli:

- **Livello 1 — Legami diretti, supportati empiricamente.**

L'accavallamento autismo-ADHD ("AuDHD") è il più forte: il MQ mostra che l'attenzione monotropica è elevata in *entrambe* le condizioni, reinquadrando lo "split monotropico" (tunnel in competizione o instabili) come un vero fenotipo attentivo misurabile [2][3][5]. Sovrapposizioni a livello di meccanismo — **interocezione**

atipica e **disfunzione esecutiva** — sono ben evidenziate e aiutano a spiegare i problemi a valle con alimentazione, disordine ed evitamento [6][7][8].

- **Livello 2 — Comorbidità indiretta a meccanismo condiviso.**
L'autismo si accavalla marcatamente con **anoressia/alimentazione restrittiva** e **OCD**. In ciascun caso la comorbidità è reale e replicata, ma il ponte *meglio evidenziato* è un meccanismo condiviso (interocezione; elaborazione ego-sintonica vs ego-distonica) più che il monotropismo specificamente [6][9][10].
- **Livello 3 — Estrapolazione plausibile o costrutti contestati.** Alcuni legami nell'inquadratura popolare — le "pile del destino" come un fallimento monotropico della permanenza dell'oggetto, l'agorafobia come esito primario del monotropismo, la **PDA** come profilo distinto — poggiano su evidenza più debole o contestata e vanno trattati come ipotesi, non fatti stabiliti [11][12][13].

Direzione dell'effetto. I livelli graduano la *forza*; non dicono in che direzione corre la causalità. Per la maggior parte dei legami la risposta onesta è un **meccanismo condiviso o un loop di feedback**, non una freccia a senso unico. La depressione è il caso-lampo più chiaro (§3.4): il suo ponte più forte verso l'autismo è il **basso mastery** — un'avvertita mancanza di controllo sulla propria vita — che è genuinamente *bidirezionale*; e l'affermazione diffusa che "il masking causa depressione" poggia su dati trasversali che uno studio longitudinale del 2025 non supporta.

In tutto, un tema ricorrente: molti comportamenti che sembrano "disturbi" separati si leggono meglio come **il costo cognitivo di un sistema attento ristretto che collide con un mondo politropico** — ma solo alcune di quelle letture sono state testate direttamente.

1. Fondamenti: cos'è il monotropismo e quanto è solido

Il monotropismo propone che le menti differiscano in come distribuiscono le risorse attentive. Una mente **politropica** tiene molti canali di interesse attivi contemporaneamente (ampia, superficiale, cambio facile); una mente **monotropica** convoglia le risorse in pochi "tunnel di attenzione" intensamente attivi (ristretta, profonda, difficile da cambiare) [1][3]. Gli estensori — Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike

Lesser — presentarono l'idea alle conferenze sull'autismo di Durham dal 1992 e la formalizzarono nel 2005, sostenendo che spiega i tratti autistici (interessi speciali, bisogno di uguaglianza, malessere alle transizioni, focalizzazione sul dettaglio) meglio dei modelli solo-deficitari [1][14].

Il suo status scientifico si è spostato negli ultimi anni:

- È **misurabile empiricamente**. Il MQ (Garau et al., 2023) è uno strumento di autovalutazione a 47 item testato su 1.110 partecipanti (756 autistici, 354 non-autistici). I partecipanti autistici e con ADHD hanno ottenuto punteggi significativamente più alti dei controlli [2][3].
- Ha un **cugino meccanicistico sottoposto a revisione paritaria**. Il modello dell'"allocazione atipica delle risorse" di Goldknopf (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operazionalizza l'intuizione: nell'autismo, le risorse attentive sono **ristrette** (a meno/aree più piccole, modalità e stadi di elaborazione, talora più intensamente) e/o **ridotte** in capacità complessiva — un quadro che lega esplicitamente insieme linguaggio, cognizione sociale, atipicità sensoriale/attentiva e differenze esecutive/motorie [4].
- Sta **accanto, non al posto di**, altre teorie cognitive (Teoria della Mente; coerenza centrale debole / stile focalizzato sul dettaglio (Happé & Frith, 2006); disfunzione esecutiva) [4][15].
- Rimane un **modello, non un biomarcatore**. Goldknopf è esplicito che è un fattore tra diversi, "molto probabilmente" saliente nelle persone autistiche con forti sintomi sensoriali [4]. Murray e colleghi inquadrano similmente il monotropismo come una *lente* unificante, non un'eziologia completa [1][14].

Implicazione per il resto della breve: il monotropismo è un'idea organizzativa credibile e sempre più validata, ma la sua *portata esplicativa* in ciascuna comorbidità va argomentata caso per caso — non data per scontata.

2. Livello 1 — Legami diretti: il cluster neuroevolutivo

2.1 AuDHD e lo "split monotropico" (*legame diretto più forte*)

Autismo e ADHD co-occorrono molto più spesso di quanto prevederebbe il caso: l'ADHD è presente in circa il **30–80%** delle persone autistiche, e l'autismo in circa il **20–50%** di quelle con ADHD [5]; una meta-analisi pone i tassi di sintomi ASD nei campioni ADHD attorno al **21%** [16]; un ampio studio Medicaid ha trovato che il **27%** degli adulti autistici senza disabilità intellettiva aveva una diagnosi di ADHD co-occorrente — circa 10× il tasso generale [17]. La sovrapposizione è in larga parte genetica (~50–72%) [18].

Il monotropismo aiuta a risolvere un vecchio enigma: se l'autismo è "iper-focus" e l'ADHD è "disattenzione", perché co-occorrono? Il MQ risponde empiricamente — **le persone con ADHD, specialmente AuDHD, sono anche altamente monotropiche** [2][3]. L'iper-focus nell'ADHD (Grotewiel et al., 2022) è concettualmente quasi identico al tunnel monotropico [19]. L'inquadratura dello "split monotropico" quindi re-inquadra l'AuDHD non come opposti ma come **un sistema instabile di tunnel di attenzione in competizione o a rapido spostamento**: il cervello richiede una focalizzazione monotropica profonda ma non riesce a stabilizzare il tunnel, producendo la familiare oscillazione AuDHD tra coinvolgimento intenso, burnout rapido e sotto-stimolazione cronica [19][20].

Caveat: il meccanismo dei "tunnel multipli in competizione" è *plausibile e coerente con i dati del MQ* ma non ancora testato direttamente come dinamica; va letto come una forte ipotesi.

2.2 Burnout autistico e rottura del tunnel

Il burnout autistico — esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza — è sempre più legato al costo cumulativo del cambio costante di tunnel, del masking e delle richieste che superano la capacità, con insufficiente tempo di recupero/flusso [20][21][38]. Questa è un'area in cui il monotropismo è euristicamente potente (ogni transizione forzata è una rottura del tunnel), anche se la letteratura sul burnout sta ancora maturando e la via monotropismo→burnout è in larga parte clinica/in prima persona più che stabilita sperimentalmente [20].

2.3 Evitamento della domanda e PDA (*costrutto contestato*)

Una domanda — "preparati", "fai questo modulo" — può essere vissuta come un'intrusione violenta in uno stato di flusso. Questo è il resoconto monotropico intuitivo dell'**evitamento della domanda**. Il costrutto più specifico **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, coniato da Elizabeth Newson negli anni '80 e ora spesso re-inquadrato come "Pervasive Drive for Autonomy", descrive un bisogno di controllo e un evitamento delle richieste ordinarie guidati dall'ansia [11][22].

Due cose vanno separate:

- **Il comportamento di evitamento della domanda è reale e comune** nell'autismo, e il resoconto monotropico della "rottura del tunnel" è una *storia meccanicistica* ragionevole per il panico e la resistenza che produce.
- **La PDA come profilo o sottotipo distinto non è stabilita.** La National Autistic Society del Regno Unito afferma che "nessuna ricerca ha trovato prove solide a favore della [PDA] come profilo distinto" [11]; lo studio fondazionale di Newson è stato criticato per **ragionamento circolare e sovra-interpretazione** (i gruppi definiti dai ricercatori erano poi "studiati") [12][13]; e le revisioni notano problemi persistenti con definizione, validità del costrutto e misurazione [23]. Una revisione del 2023 si intitola pointedly "*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*" [13].

Quindi l'inquadratura del testo-seme è per metà giusta: l'*esperienza* (una richiesta frantuma il tunnel) è ben descritta dal monotropismo; l'*entità diagnostica* (PDA) è contestata e non va presentata come acquisita.

3. Livello 2 — Comorbidità indiretta a meccanismo condiviso

3.1 Anoressia e alimentazione restrittiva

L'accavallamento autismo–anoressia è robusto e bidirezionale: all'incirca il **20–30%** dei pazienti con disturbi alimentari mostra tratti autistici clinicamente significativi, con i tassi più alti nell'anoressia nervosa e nell'ARFID [6][24]; viceversa, gli adulti autistici hanno tassi elevati di

disturbi alimentari. Fondamentalmente, i tratti autistici si osservano **prima** dell'insorgenza del DA, quindi l'accavallamento non è un mero effetto dell'inedia [6].

Il ponte *meccanicistico* meglio evidenziato è l'**interocezione** — la percezione dei segnali corporei interni (battito, sazietà).

Un'interocezione atipica è implicata nell'eziologia *sia* dell'autismo *sia* dei disturbi alimentari e "può, almeno in parte, essere responsabile" della loro comorbidità [6]. La stessa atipicità interolettiva sta alla base dell'**alessitimia** (difficoltà a identificare/verbalizzare le emozioni), presente in ~50% delle persone autistiche e essa stessa legata alla patologia alimentare [7][8].

Dove il monotropismo entra (e non entra): è ragionevole dire che una persona monotropica immersa in un tunnel possa *non cogliere* i segnali della fame — ma l'affermazione specifica del testo-seme che "il monotropismo riduce l'interocezione" sopravvaluta la catena causale. La relazione evidenziata è **autismo** → **interocezione/alessitimia atipiche** → **vulnerabilità alimentare**; il monotropismo è una caratteristica parallela dell'autismo, non la *causa* dimostrata della differenza interolettiva [6][7]. Il tracciamento di cibo/calorie può anche diventare un tunnel a sé, ma questo è plausibile a livello di meccanismo più che testato.

3.2 OCD vs iper-focus: una distinzione genuina

Autismo e OCD co-occorrono sostanzialmente: ~17% delle persone autistiche soddisfa i criteri per OCD, vs ~1–2% nella popolazione generale [9]. Nonostante la somiglianza superficiale (comportamento ripetitivo, rigidità), il **driver affettivo differisce** e questo è ben stabilito clinicamente:

- Gli interessi e le routine ristrette/ripetitive **autistiche** sono tipicamente **ego-sintonici** — piacevoli, autocalmanti, guidati dall'interesse, spesso regolatori.
- Le compulsioni **OCD** sono **ego-distoniche** — indesiderate, guidate dall'ansia, eseguite per neutralizzare gli esiti temuti [9][10].

La distinzione del testo-seme è quindi corretta e supportata dall'evidenza, ed è confermata direttamente dagli stessi partecipanti autistici: in uno studio qualitativo hanno riferito che i comportamenti ripetitivi sono "parte di chi sono", mentre i sintomi OCD "entravano in

conflitto con come vedono sé stesse/i" [10]. Lo stesso studio inquadra acutamente la co-occorrenza come "*Autism is the arena and OCD is the lion*" — i sintomi OCD possono "dirottare" gli interessi speciali autistici, gonfiandone intensità e malessere [10]. Il monotropismo aggiunge contesto (un tunnel può essere *catturato* da contenuti OCD) ma la differenziazione poggia sull'asse ego-sintonico/distonico, non sul monotropismo in sé.

3.3 Ansia e disturbi affettivi (il substrato sotto "agorafobia")

L'ansia è tra le comorbidità dell'autismo più comuni (una revisione secondaria cita ≥ 1 comorbidità psichiatrica in ~86% delle persone autistiche) [25]. Due punti di meccanismo contano per il cluster comportamentale qui sotto: (i) l'**iper-responsività sensoriale** e l'ansia sono legate, e attraverso il *condizionamento di contesto* producono **evitamento comportamentale di luoghi generalizzati** (ristoranti, negozi, feste) [26]; (ii) la frequente co-occorrenza di alessitimia/difficoltà interocettiva fa sì che gli stati emotivi siano spesso male-etichettati, alimentando un'ansia diffusa [7].

3.4 Depressione, mastery e il loop di feedback (*direzione dell'effetto*)

I livelli sopra graduano *quanto sia forte* ciascun legame; la domanda più difficile è **in che direzione corre** — il monotropismo guida una condizione, la condizione amplifica l'*apparenza* del monotropismo, o si rinforzano a vicenda? La depressione è il caso più chiaro su cui lavorare questo, perché è comune, ben studiata e — unicamente in questa rete — ha un ponte *bidirezionale* misurato.

Prevalenza. La depressione negli adulti autistici corre ben al di sopra dei tassi della popolazione generale: una meta-analisi (Hollocks et al., 2019; ~26.000 adulti autistici) pone la depressione corrente al **23%** e la lifetime al **37%** (ansia: 27% / 42%) [33]. Negli adolescenti autistici circa **uno su tre** vive un episodio depressivo, con sintomi che crescono lungo gli anni dell'adolescenza; dati di resoconto-genitoriale pongono le diagnosi di depressione a ~**20%** degli autistici 13–17enni vs ~**8%** degli adolescenti tipicamente sviluppati [34][35].

Il ponte del mastery (il meccanismo bidirezionale). La scoperta meccanicistica più utile per la *direzione* è van Heijst, Deserno, Rhebergen & Geurts (2020), un'analisi di rete in due studi (258 adulti depressi più

anziani di 60–90 anni; 173 adulti autistici). I sintomi sovrapposti **non** spiegano pienamente perché autismo e depressione co-occorrono. Il nodo di collegamento è il **mastery** — il senso avvertito di controllo sulla propria vita. Sia gli adulti depressi che quelli autistici riportavano molte preoccupazioni e basso controllo [36]. Letto in termini monotropici: un sistema attentivo ristretto costretto a operare politropicamente è cronicamente *frustrato*; la frustrazione cronica erode l'agenzia; la bassa agenzia è un motore della depressione; e un episodio depressivo erode ulteriormente l'agenzia — un genuino **loop di feedback (monotropismo ↔ mismatch-col-mondo → basso mastery ↔ depressione)**. Questa è la via bidirezionale meglio evidenziata in tutta la rete.

La freccia masking → depressione è più debole di quanto sembri. Il resoconto diffuso — le persone autistiche camuffano, lo sforzo causa depressione — poggia quasi interamente su dati **trasversali**. Un raro studio longitudinale (van der Putten et al., 2025; n=332 adulti autistici, età 30–84, ~2 anni di intervallo) ha trovato che il camuffamento **non** prediceva un peggioramento della salute mentale nel tempo, e semmai mostrava un piccolo effetto *protettivo*; anche la freccia inversa (umore al baseline che prediceva camuffamento successivo) era non-significativa [37]. Gli autori avvertono che l'effetto era piccolo, il campione sbilanciava verso adulti più anziani/di diagnosi tardiva, e il questionario sul camuffamento misura la *frequenza*, non il *costo* [37]. La conclusione non è "il masking è innocuo" — il suo costo in esaurimento è reale (§2.2) — ma che **la direzione non è provata**, e il meccanismo corre attraverso l'agenzia (mastery), non lo sforzo da solo.

Burnout → depressione (e la distinzione che conta). Il burnout autistico (§2.2) è una sindrome distinta — Raymaker et al. (2020) lo definiscono come stress di vita cronico + un mismatch aspettative/capacità senza supporti adeguati, della durata di ≥ 3 mesi, con esaurimento pervasivo, perdita di funzione e ridotta tolleranza agli stimoli [38]; Mantzalas et al. (2022) confermano il masking/soppressione come driver primari [39]. **Non** è depressione: le caratteristiche del burnout includono sovraccarico sensoriale, perdita della capacità di mascherare e "ideazione di non-esistenza" (voler non esistere per esaurimento), mentre il ritiro sociale è *adattivo* nel burnout ma *disadattivo* nella depressione [38][39]. La via in avanti è chiara — il burnout è una delle principali vie verso la depressione autistica e la

suicidalità — così burnout e depressione formano una sequenza e un loop di feedback. Confonderli rischia di trattare un problema di riposo/sensorialità come un disturbo dell'umore (o viceversa).

La freccia inversa (un'inferenza, segnalata). La depressione restringe dimostrabilmente l'attenzione: un scarso controllo attentivo è una via documentata verso la ruminazione [40]. Durante un episodio depressivo un profilo monotropico può quindi *apparire* più pronunciato — meno tunnel attivi, più tempo bloccato in uno negativo — il che può far intrecciare statisticamente depressione e autismo e rischiare "diagnostic overshadowing" (sintomi umorali attribuiti all'autismo stesso). **Nessuno studio ha misurato se i punteggi MQ salgono durante un episodio depressivo;** questa è un'ipotesi, non un dato [36].

Lungo l'arco di vita. Negli adulti autistici più anziani, le difficoltà di salute mentale **persistono e non migliorano con l'età** (Roestorf, Howlin & Bowler, 2022; 68 adulti, 19–80, ~2,4 anni di follow-up; 71% con ≥ 1 condizione co-occorrente) [41]; e il ponte del mastery è stato dimostrato in una coorte di 60–90enni [36], così lo stesso loop opera nella fascia d'età più sotto-studiata. **Non esiste uno studio di prevalenza dedicato alla depressione negli adulti autistici anziani (70+)** — la più grande lacuna lungo l'arco di vita in questo brief.

4. Livello 3 — Cluster comportamentale/funzionale: disordine, accumulo, evitamento, ritiro sociale

4.1 Disordine, "pile del destino" e disfunzione esecutiva

Il *fenomeno* è ben supportato: persone autistiche e con ADHD mostrano alti tassi di disorganizzazione e disordine, e la via meglio evidenziata è la **disfunzione esecutiva** — deficit di categorizzazione, decision-making, pianificazione e memoria di lavoro [8][27]. I sintomi di accumulo sono elevati sia nell'ADHD (con uno "speciale legame con la disattenzione" [8a]) sia nell'autismo [8]; nell'autismo specificamente, lavori qualitativi mostrano che la difficoltà a scartare è legata a **attaccamenti di interesse e significato**, non solo al valore dell'oggetto [28].

Caveat sul testo-seme: l'affermazione specifica che il disordine persiste a causa di un **"deficit di permanenza dell'oggetto" autistico** ("lontano dagli occhi, lontano dalla mente") **non è supportata da evidenza**

sottoposta a revisione paritaria che io abbia potuto reperire. La permanenza dell'oggetto è tipicamente *intatta o superiore* nell'autismo; l'esperienza "lontano dagli occhi, lontano dalla mente" si legge meglio come un effetto di **memoria di lavoro/allocazione dell'attenzione** (una mente a tunnel non si ri-orienta agli oggetti immagazzinati) più che come un fallimento percettivo della permanenza dell'oggetto. Il meccanismo evidenziato per il disordine resta **disfunzione esecutiva più attaccamento-all'interesse**, che si accavalla alla popolazione monotropica/AuDHD ma non è unicamente "monotropico" [4][8][28].

4.2 Comportamento dello spettro dell'accumulo

Il disturbo da accumulo colpisce ~1,5–6% della popolazione generale ma è elevato nell'autismo [29]. Negli adulti autistici, la difficoltà di accumulo-simile a scartare è spesso riportata accanto a **difficoltà cognitive (esecutive) e forti attaccamenti di interesse/significato** — gli oggetti sono nodi in una rete di idee e utilità futura, quindi scartarli sembra una perdita [28]. Questo è coerente con uno *stile* monotropico (elaborazione profonda degli oggetti) ma, ancora, il driver evidenziato è EF/attaccamento, condiviso tra le condizioni neuroevolutive [8].

4.3 Agorafobia e delimitazione dello "spazio sicuro" (*da correggere*)

Il testo-seme inquadra il confinamento domestico agorafobico come un esito del monotropismo quasi diretto. I dati sono più sfumati:

- L'agorafobia è elevata nell'autismo — ~**23–25%** degli adulti autistici (senza disabilità intellettiva) vs ~1,3% nella popolazione generale — **ma è meno comune della fobia sociale o del GAD**, e l'effetto si concentra in chi è senza DI [25].
- Il driver meglio evidenziato è l'**iper-responsività sensoriale + ansia sociale**, con evitamento condizionato al contesto dei luoghi soverchianti — cioè il comportamento di "spazio sicuro" è reale ma è **secondario all'ansia sensoriale/sociale**, non un fenomeno monotropico primario [25][26].

Quindi: il monotropismo aiuta a spiegare *perché* il mondo esterno si sente dirompente (imprevedibile, politropico, frantuma-tunnel), ma classificare il confinamento risultante come "agorafobia" specifica del monotropismo sopravvaluta il legame. È un evitamento guidato dall'ansia sensoriale che *si accavalla* all'esperienza monotropica.

4.4 Ritiro sociale, "info-dumping" e il problema della doppia empatia

L'interazione sociale è genuinamente politropica — richiede di seguire simultaneamente volti, tono, gerarchia, tempistica e regole non scritte — quindi è sproporzionatamente costosa per un sistema monotropico, un punto coerente col modello di risorse di Goldknopf [4]. L'intuizione del testo-seme è fondata.

Ma l'inquadratura più acuta ed *empiricamente supportata* per la risultante rottura della comunicazione è il **Problema della Doppia Empatia** (Milton, 2012; 2017): la difficoltà è *bidirezionale* e relazionale — una "rottura nella reciprocità tra due attori sociali disposti in modo diverso" — non un deficit empatico unidirezionale nella persona autistica [30]. Lavori empirici mostrano ora che gli osservatori non-autistici *rilevano e dimostrano* il problema della doppia empatia nelle interazioni miste [31]. L'"info-dumping" si inserisce naturalmente: è una comunicazione che cerca profondità da un sistema monotropico, che fallisce quando il partner non può eguagliare la profondità — un disallineamento di stili di elaborazione, non una mancanza di empatia [30][31].

Lacuna da segnalare: la letteratura sul PDE esclude ancora in larga parte i bambini autistici, le persone non-parlanti e le persone con disabilità intellettiva, quindi la generalizzabilità è limitata [32].

5. Il confine: dove il resoconto monotropico si spinge troppo oltre

Affermazione nell'inquadratura di seme/divulgativa	Status dell'evidenza	Inquadratura migliore
Il monotropismo <i>causa</i> le caratteristiche dell'autismo	Parzialmente supportato (MQ; Goldknopf)	Un fattore organizzativo validato tra diversi; più forte nell'autismo con sensorialità presente [1][4]

Affermazione nell'inquadratura di seme/divulgativa	Status dell'evidenza	Inquadratura migliore
AuDHD = "split monotropico" (tunnel in competizione)	Forte + direttamente misurabile (MQ)	Un fenotipo attentivo reale; il meccanismo dinamico è a livello di ipotesi [2][3]
La PDA è un profilo autistico distinto	Contestato	L'evitamento della domanda è reale; la PDA-com entità manca di validità di costruito [11][12][13]
Il monotropismo <i>riduce l'interocezione</i> → anoressia	Indiretto	Il ponte è autismo→interocezione/alessitimia→vulnerabilità DA; il monotropismo è parallelo, non la causa mostrata [6][7]
Disordine da un "deficit di permanenza dell'oggetto"	Non supportato	Disfunzione esecutiva + attaccamento-all'interesse; nessun deficit percettivo di permanenza dell'oggetto evidenziato [4][8][28]
Agorafobia come esito primario del monotropismo	Sopravvalutato	Secondaria a iper-responsività sensoriale + ansia sociale; meno comune di GAD/fobia sociale [25][26]
OCD vs "ossessioni" monotropiche differiscono per affetto	Ben supportato	Ego-distonico (OCD) vs ego-sintonico (interesse autistico); l'OCD può "dirottare" i tunnel [9][10]
Il Problema della Doppia Empatia spiega la rottura sociale	Supportato (ma lacune)	Disallineamento bidirezionale; i campioni sbilanciano verso adulti parlanti senza DI [30][31][32]
Il masking <i>causa</i> la depressione	Solo trasversale	Direzione non provata; uno studio longitudinale di 2 anni non ha trovato peggioramento (effetto piccolo, campione più anziano/di diagnosi tardiva) [37]
La depressione come loop di feedback monotropico	Supportato (meccanismo)	Bidirezionale via basso mastery [36]; la depressione può amplificare l'apparenza del monotropismo durante un episodio (inferenza, non testata)

6. Questioni aperte

1. **Test dinamico del tunnel.** Il MQ è una misura di *tratto*. Lo "split monotropico" (tunnel in competizione/instabili nell'AuDHD) è osservabile in attenzione/EEG in tempo reale? In gran parte non testato.
2. **Freccia causale verso l'interocezione.** Una distribuzione monotropica delle risorse *produce* un'atipicità interolettiva, o condividono una causa a monte comune? L'evidenza attuale non sa separarle [6][7].
3. **Risoluzione della PDA.** La ricerca sull'evitamento della domanda convergerà su un costrutto validato e misurabile, o rimarrà una categoria divulgativa/clinica contestata? [11][13]
4. **Meccanismo del disordine.** "Lontano dagli occhi, lontano dalla mente" è un effetto di memoria di lavoro/allocazione (plausibile) o altro? Nessuno studio dedicato trovato.
5. **Generalizzabilità del PDE.** Come opera il problema della doppia empatia per le persone autistiche non-parlanti, i bambini e le persone con disabilità intellettiva co-occorrente? [32]
6. **Burnout.** Qual è lo specifico contributo testabile della rottura del tunnel monotropico al burnout autistico vs masking, trauma e domanda cronica? [20]
7. **Un episodio depressivo alza i punteggi MQ?** La freccia inversa (depressione → un profilo monotropico più pronunciato) è plausibile ma non misurata [36][40].
8. **Prevalenza negli anziani.** Nessuno studio dedicato alla depressione in adulti autistici 70+; la base di evidenza sulla salute mentale nell'invecchiamento è sottile [41].

Fonti

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]

Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ).

Open Science Framework (preprint). Commentario/sintesi:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; mirror: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — sintesi dei risultati del MQ (47 item; N=1.110; autistici + ADHD ottengono punteggi significativamente più alti):
<https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — rassegna sulla comorbidità ADHD e autismo (ADHD in ~30–80% di ASD; ASD in ~20–50% di ADHD; cita Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019):
<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50% delle persone autistiche ha alessitimia, mediata da deficit interocettivi.
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] lo "speciale legame con la disattenzione" è il sottotitolo stesso del paper. Si veda anche il Drake Institute su ADHD/disfunzione esecutiva:
<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — sintesi di revisione sistematica: ~17% delle persone autistiche soddisfa i criteri per OCD vs ~1–2% generale; distinzione ego-sintonico vs ego-distonico:
<https://animosanopsychiatry.com/blog/oed-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativo).

PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance ("nessuna ricerca ha trovato prove solide a favore della [PDA] come profilo distinto"): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA — critica del ragionamento circolare di Newson (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (citato via studio comparativo Frontiers 2024): <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (citato via Psych Scene Hub e Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27% degli adulti autistici senza DI aveva ADHD co-occorrente (~10× generale): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — sintesi della sovrapposizione genetica (~50–72%): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-audhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD come tunnel in competizione; riferisce Grotewiel et al. 2022 sull'iper-focus dell'ADHD): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (stati di flusso; riferisce Heasman et al. 2024 "autistic flow theory"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, anni '80; re-inquadratura "Pervasive Drive for Autonomy"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et

al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (cita anche Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobia nell'autismo ~23–25% (senza DI) vs ~1,3% generale; meno comune di fobia sociale/GAD (fonte secondaria, attinge a Helles et al. 2020 e Lugnegård et al. 2012):
<https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — condizionamento di contesto ed evitamento. PMC2980623.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (funzione esecutiva, decision-making):
<https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (qualitativo). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8).
<https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887; estensione di Milton (2017). Sintesi: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia — Double empathy problem (lacune di ricerca riconosciute: bambini, non-parlanti, disabilità intellettiva):
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem [33] Hollocks, M. J., Lerh, J. W., Magiati, I., Meiser-Stedman, R., & Brugha, T. S. (2019).

Anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*.
 Depressione corrente 23%, lifetime 37%; ansia corrente 27%, lifetime 42%. <https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/anxiety-and-depression-in-adults-with-autism-spectrum-disorder-a-systematic-review-and-metaanalysis/CDC4FF29C3DC504768E375EE65019E0C> ; sintesi: <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/anxiety-and-depression-in-adults-with-autism-spectrum-disorder-a-> [34] Autistica — Depression and autism (~1 adolescente autistico su 3 vive un episodio depressivo; cita la meta-analisi di Hudson et al. 2019 e Lever & Geurts 2016): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/depression-and-autism> [35] *Depression in youth with autism spectrum disorder* (resoconto-genitoriale dell'Autism Treatment Network: ~20% degli autistici 13–17enni vs ~8% tipicamente sviluppati). PMC6512853: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6512853> ; e *Trajectory of depressive symptoms over adolescence in autistic and neurotypical youth* (2024), *Molecular Autism*: <https://doi.org/10.1186/s13229-024-00600-w> [36] van Heijst, B. F. C., Deserno, M. K., Rhebergen, D., & Geurts, H. M. (2020). Autism and depression are connected: a report of two complimentary network studies. *Autism*. Il mastery (senso di controllo) è il nodo di collegamento tra tratti autistici e depressione; i sintomi sovrapposti non spiegano pienamente la co-occorrenza. <https://doi.org/10.1177/1362361319872373> (PMC7168804: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7168804>) [37] van der Putten, W. J., Mol, A. J., Radhoe, T. A., Torenvliet, C., Agelink van Rentergem, J. A., Groenman, A. P., & Geurts, H. M. (2025). Camouflaging in autism: a cause or a consequence of mental health difficulties? *Autism*. Longitudinale, n=332, età 30–84, ~2 anni di intervallo; il camuffamento non prediceva un peggioramento della salute mentale nel tempo. <https://doi.org/10.1177/13623613251347104> (sintesi: <https://www.simplypsychology.org/news/camouflaging-in-autism-may-not-drive-mental-health-problems>) [38] Raymaker, D. M., Teo, A. R., Steckler, N. A., Lentz, B., Scharer, M., Delos Santos, A., Kapp, S. K., Hunter, M., Joyce, A., & Nicolaidis, C. (2020). “Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew”: defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*. <https://doi.org/10.1089/aut.2019.0079> [39] Mantzalas, J., Richdale, A. L.,

Adikari, A., Lowe, J., & Dissanayake, C. (2022). What is autistic burnout? A thematic analysis of posts on two online platforms. *Autism in Adulthood*. <https://doi.org/10.1089/aut.2021.0021> (PMC8992925: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8992925>) [40] Hsu, K. J., Beard, C., Rifkin, L., Dillon, D. G., Pizzagalli, D. A., & Björgvinsson, T. (2015). Transdiagnostic mechanisms in depression and anxiety: the role of rumination and attentional control. *Journal of Affective Disorders*. Scarso controllo attentivo come via verso la ruminazione. https://depressioninstitute.uci.edu/wp-content/uploads/sites/37/hsu_jad15.pdf [41] Roestorf, A., Howlin, P., & Bowler, D. M. (2022). Ageing and autism: a longitudinal follow-up study of mental health and quality of life in autistic adults. *Frontiers in Psychology*. 68 adulti, 19–80, ~2,4 anni di follow-up; le difficoltà di salute mentale persistono in età più avanzata e non migliorano. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.741213>

Nota sui livelli di evidenza: Livello 1 = misurazione diretta e replicata (MQ; tassi AuDHD); Livello 2 = comorbidità replicata con un meccanismo condiviso evidenziato; Livello 3 = estrapolazione plausibile, a fonte singola o costruito contestato. Si veda §5.